FOIE · FO-02

# LI-RADS · échographie et CEUS

**US Surveillance v2024 · CEUS v2017**
surveillance du CHC et échographie de contraste

## ÉCHOGRAPHIE DE SURVEILLANCE · LI-RADS US SURVEILLANCE V2024

**Population :** cirrhose Child-Pugh A ou B (et C si candidat à la greffe) ; hépatite B chronique sans cirrhose à risque (homme > 40 ans ou femme > 50 ans de zone d'endémie, origine africaine ≥ 20 ans, antécédent familial de CHC, PAGE-B ≥ 10) ; cirrhose virale C guérie (risque ≥ 10 ans). Pas de surveillance systématique en fibrose F3. Rythme : **tous les 6 mois**, en ambulatoire.

### Catégorie de l'examen

| CATÉGORIE | DÉFINITION | CONDUITE |
|---|---|---|
| **US-1** négatif | Aucune observation ou seulement bénigne certaine (kyste, stéatose ou épargne focale typique, hémangiome connu, < 10 mm stable sur 2 contrôles) | Échographie à 6 mois |
| **US-2** infra-seuil | Observation(s) **< 10 mm** non certainement bénigne(s) | **2 contrôles à 3–6 mois** ; si stable < 10 mm → US-1 |
| **US-3** positif | Observation **≥ 10 mm**, distorsion parenchymateuse ≥ 10 mm, ou **nouveau thrombus** porte ou sus-hépatique | Scanner ou IRM multiphasique, ou CEUS |

La catégorie s'applique à l'examen entier (observation la plus suspecte) ; en cas de doute, choisir la plus suspecte.

### Score de visualisation

| SCORE | DÉFINITION | CONDUITE |
|---|---|---|
| **VIS-A** | Limitations nulles ou minimes | Selon la catégorie US |
| **VIS-B** | Limitations modérées pouvant masquer des lésions < 10 mm | Selon la catégorie US (sensibilité > 75 %) |
| **VIS-C** | Limitations sévères ; > 50 % du diaphragme ou d'un lobe non vus | **Nouvelle échographie ≤ 3 mois** ; si VIS-C répété ou facteurs de risque (MASH, alcool, Child B/C, IMC ≥ 35) : IRM abrégée, IRM ou scanner |

Sensibilité de l'examen VIS-C pour le CHC : < 30 %. Balayages vidéo (« cine sweeps ») recommandés.

**AFP élevée avec cible échographique**
(≥ 20 ng/mL, doublement ou hausse sur 2 dosages) → scanner, IRM ou CEUS

**AFP élevée sans cible**
scanner ou IRM multiphasique (pas de CEUS) ; si négatif et AFP ≥ 200 : autre modalité, voire bilan extra-hépatique

## ÉCHOGRAPHIE DE CONTRASTE · CEUS LI-RADS V2017

### Tableau diagnostique

| | PAS DE WASH-OUT | WASH-OUT TARDIF ET MODÉRÉ |
|---|---|---|
| **Pas d'APHE**, < 20 mm | LR-3 | LR-3 |
| **Pas d'APHE**, ≥ 20 mm | LR-3 | LR-4 |
| **APHE**, < 10 mm | LR-3 | LR-4 |
| **APHE**, ≥ 10 mm | LR-4 | LR-5 |

APHE non périphérique et non globulaire discontinu (sinon : hémangiome ou LR-M). Le nodule doit être visible en mode B.

### Le wash-out en CEUS

| WASH-OUT | SIGNIFICATION |
|---|---|
| **Tardif** (≥ 60 s) **et modéré** | Typique du CHC → critère majeur |
| **Précoce** (< 60 s) | Évoque un cholangiocarcinome ou une métastase → LR-M |
| **Marqué** (lésion « vide » en < 2 min) | |

CRITÈRES LR-M

APHE **en anneau**, wash-out précoce ou wash-out marqué

TECHNIQUE

SonoVue (agent intravasculaire pur) : observer jusqu'à **≥ 5 min** ; plusieurs injections possibles pour plusieurs nodules

## PIÈGES

**Agent**
avec un agent à phase de Kupffer (Sonazoid), les règles diffèrent

**Wash-out tardif**
un wash-out qui devient marqué après 2 min reste « modéré »

**CEUS ≠ scanner/IRM**
le CEUS ne fait pas le bilan d'extension : scanner ou IRM restent nécessaires

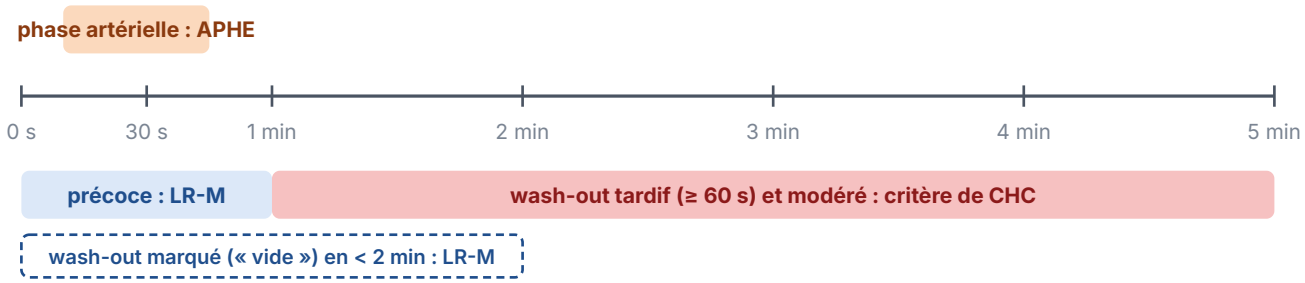
**LR-TIV**
tissu rehaussé dans une veine, quel que soit le nodule

# LI-RADS · échographie et CEUS (suite)



## ATLAS VISUEL

### Chronologie du wash-out en CEUS




Observer au moins 5 minutes (SonoVue) · Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**LI-RADS US Surveillance**
Radiopaedia · catégories US et VIS
radiopaedia.org/articles/li-rads-us-surveillance

**CEUS LI-RADS**
Radiopaedia · tableau diagnostique
radiopaedia.org/articles/ceus-li-rads-2

**LI-RADS US v2024 (PDF)**
Texte de la mise à jour
geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/upl

**Sources :** LI-RADS US Surveillance v2024 (Radiology 2024) – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · CEUS LI-RADS v2017 Core – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/LI-RADS/CEUS-LI-RADS-2017-... · LI-RADS: Current Status (KJR 2024) – kjronline.org/DOIx.php?id=10.3348/kjr.2024.0161